PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Imagem no esporte

Cinco erros diante do achado incidental

Lesões: Mecanismos, Epidemiologia e Prevenção

CASO ILUSTRATIVO

Corredora na casa dos quarenta, dor no joelho há três semanas, ressonância na mão.

casa dos quarenta
corre três vezes por semana

dor no joelho há três semanas, desde que aumentou o ritmo

laudo de ressonância

- lesão horizontal do menisco medial
- condropatia patelar grau dois
- edema ósseo subcondral

“Vou ter que operar?”

“Vou poder voltar a correr?”

O papel virou o assunto

A dor

· três semanas

· começou quando o ritmo subiu

· **é o que ela veio resolver**

saiu do centro

O laudo

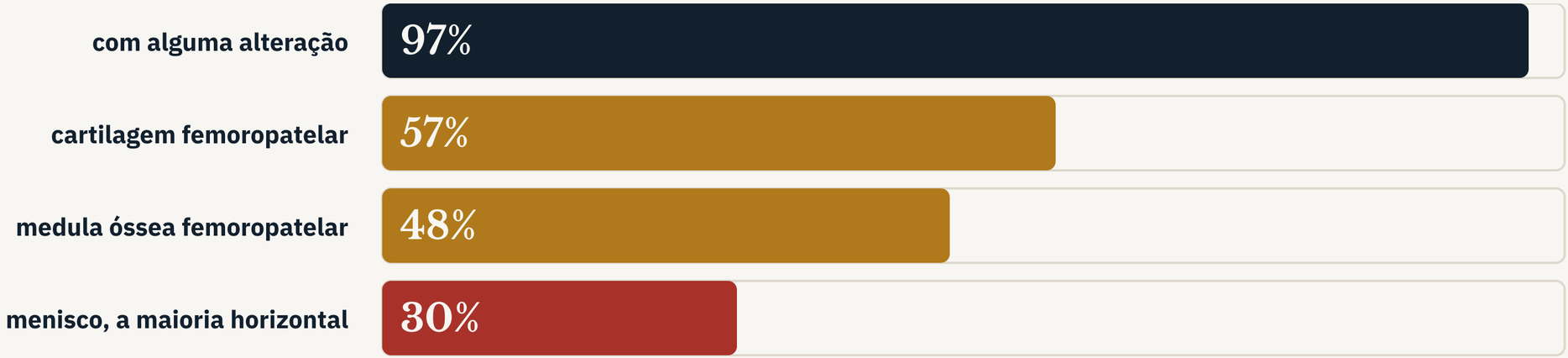
· três achados

· ocupou o centro da conversa

· **agora o assunto é o menisco**

> O problema quase nunca é o exame. É o que a gente faz com ele.

230 joelhos de adultos sem dor, sem lesão



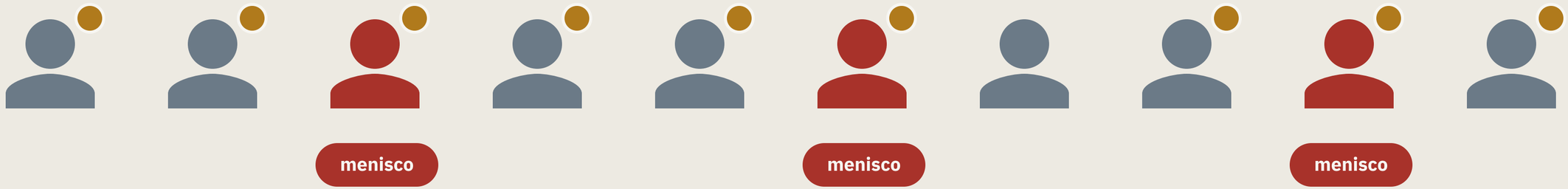
dos 230 joelhos, de 115 adultos sedentários sem queixa

Mediana de 44 anos. Ninguém sentia dor.

Skeletal Radiol 2020

NA PRÁTICA

O menisco já estava lá antes da dor, e vai continuar lá depois.

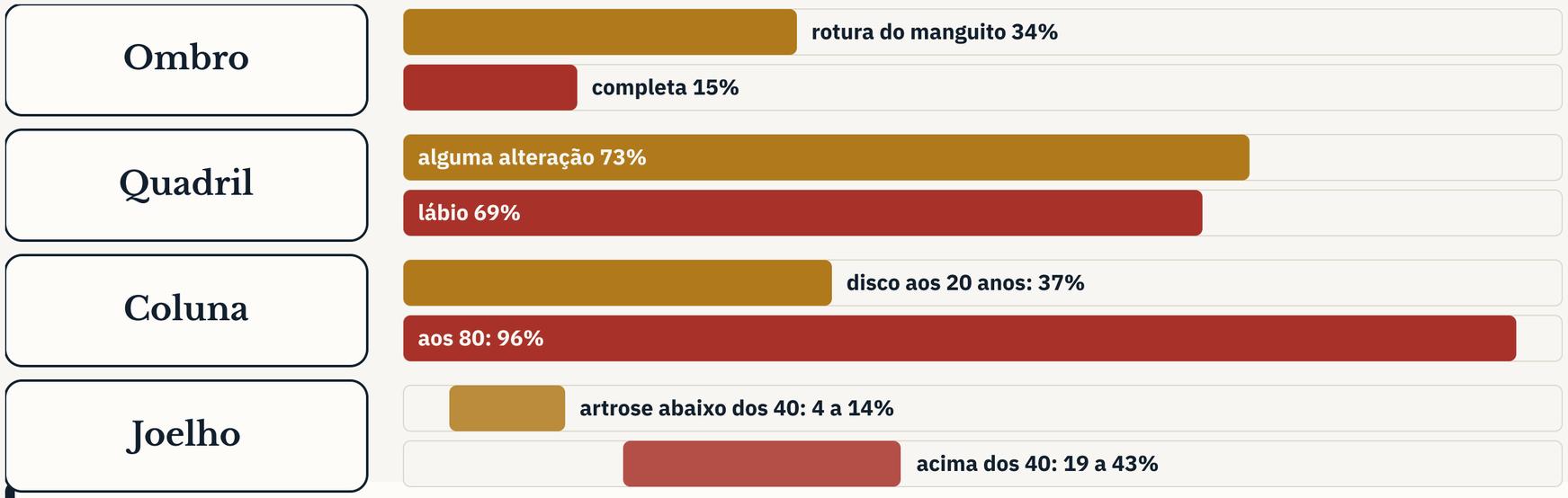


alguma coisa no laudo: quase todas

menisco: três em dez

Menisco pode doer, mas a presença do achado não prova que ele é a causa.

O mesmo padrão no corpo inteiro, em gente sem dor



Não é doença: é o tecido ao longo do tempo, como cabelo branco. Ninguém faz ressonância do cabelo.

J Bone Joint Surg Am 1995 · Am J Sports Med 2012 · AJNR 2015 · Br J Sports Med 2019

Três perguntas antes de qualquer exame

1

O que eu estou suspeitando?

sem completar “quero saber se tem”, é ansiedade, não indicação

2

O resultado muda a conduta?

se faço o mesmo com laudo normal e alterado, não é agora

3

E o achado que eu não procurei?

ele vai vir; decida antes o que fazer com ele

→ **aí, o exame**

Auditoria de um mês: anote cada exame pedido e se mudou a conduta.

Feitas para descrever tecido, lidas com medo

Degeneração

lida como fim

Rotura

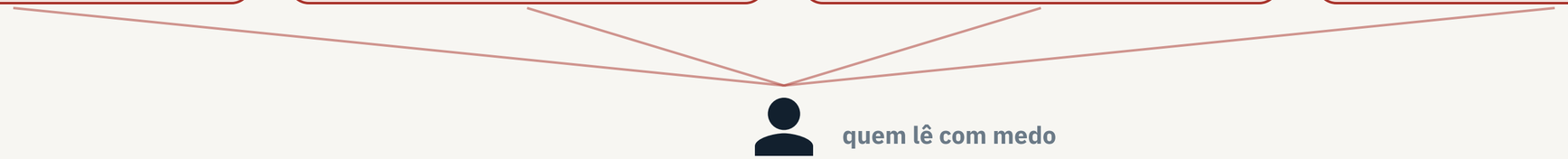
lida como algo partido

Lesão

lida como dano novo

Desgaste

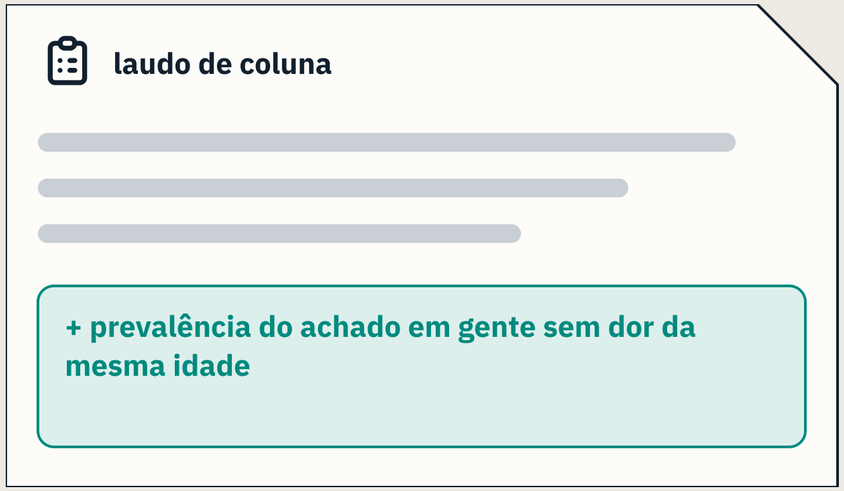
lida como prazo de validade



> Tem gente que para de correr porque leu “desgaste”. Ninguém mandou parar.

E SE O LAUDO FOSSE ESCRITO MELHOR?

Prevalência dentro do laudo de coluna



250.401 adultos no ensaio randomizado

98 clínicas de atenção primária

→ efeito **pequeno** sobre o que veio depois

> A frase no papel não substitui a conversa. Quem desarma o laudo é quem está na frente do paciente.

JAMA Netw Open 2020

COMO DIZER

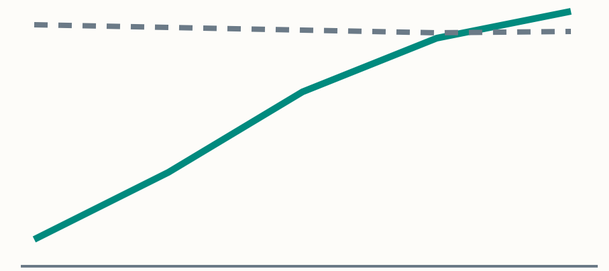
“Essas alterações são comuns na sua idade, e a maioria de quem tem não sente dor.”

“O que explica a sua dor é o que mudou no treino nas últimas semanas, e é isso que a gente vai ajustar.”

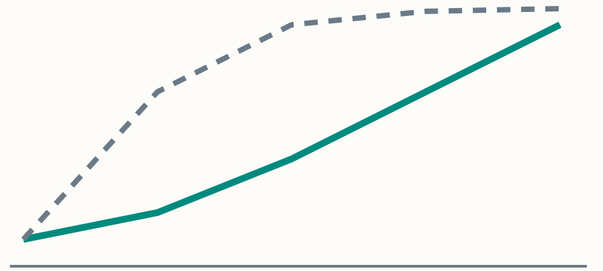
não é consolo:
é informação correta

A imagem de controle engana nos dois sentidos

Tendão



Músculo



o retorno se decide por função · esquema

Exceções

- lesão óssea em sítio de alto risco
- suspeita de complicação
- quadro que não segue o esperado

O OUTRO LADO DA BALANÇA

Quando pedir é obrigação

Trauma

não apoia ou dor óssea localizada; regra de Ottawa

Joelho que incha em horas

depois de torção

Osso de alto risco

virilha, frente da tíbia, meio do pé

Bloqueio articular

trava e não completa o movimento

Sinais sistêmicos

dor noturna, febre, perda de peso; déficit neurológico

Tratamento bem feito falhou

a imagem entra na revisão do diagnóstico

CASO ILUSTRATIVO · O PLANO

O laudo continua correto; só deixa de mandar na conversa

- Examinar e perguntar o que mudou no treino
- Ler o laudo com ela, com os números de quem não sente dor
- Tratar a dor com ajuste de carga e força

Médico

Indica a imagem e interpreta no contexto clínico.

Todo profissional

Traduz o laudo sem reforçar o medo.

Fisioterapia e preparação

Tratam a função.

Próxima aula, a última do módulo: prevenção, eficácia e adesão.